جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : ياسمين خلف عبدالغني على
المحافظة : المنيا **الحي / المدينة :** دير مواس **العنوان :** مممممممممممم
رقم البطاقة : 28607072400281 **رقم التليفون :** 01122917564 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 07-07-1986 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ياسمين خلف عبدالغني علي
National ID: 28607072400281

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ياسمين
خلف عبدالله حنى
٦٦ش الشريف حزاوية ابو مسلم
مركز ابو النمرس - الجيزة

٢٨١٠٠٢٤٠٧٠٧٢٨٦

JN1701553



٢٨١٠٠٢٤٠٧٠٧٢٨٦٠٧ ٢٠٢٢/٠٨
ربة منزل

انثى مسلمة متزوجة
رضا فضل عبدالحميد عبدالله
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٨/٢٥



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

DR Hany Barsoum
PATHOLOGY LAB

د/ هاني بطرس برسوم
استوراه تحاليل الأنسجة و الاورام (عين شمس)
استشاري بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

Age; 35Y/O
Date: 21/7/2020
اسم المريض:ياسمين خلف عبد الغني
محول من أ.د: السيد ابو صفين
Clinical Picture; Right Breast Mass with Enlarged Lymph Node
Nature of the Specimen; Fine Needle Aspiration

PATHOLOGY REPORT

Gross Examination:

Right breast: Ill- defined firm mass measures 2.5x1.5cm, located at 9 o'clock, 6cm from the nipple. Axilla shows firm nodules; largest is 1cm in diameter. FNAB was performed from both breast mass and axillary node; 5 smears and two cell blocks were prepared and examined.

Microscopic Examination:

Smears prepared from both breast mass and axillary lymph node are cellular; discohesive anaplastic ductal cells form clusters and sheets with no myoepithelium. Cells show large angulated and molding nuclei. Background is thick esinophilic.

Right Breast Mass and Axillary Lymph Node, FNAB; ALL SMEARS ARE POSITIVE FOR DUCT CARCINOMA; PICTURE OF INVASIVE DUCT CARCINOMA WITH AXILLARY LYMPH NODE METASTASIS

19/8/2020

111/8

Sincerely

Name: ياسمين خلف عبدالغني علي **MR. :** 8524	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented for administration of a 10.8 mg dose of Zoladex and continuation of tamoxifen therapy, along with supportive treatment for a three-month period, with an annual assessment scheduled for 30-11-2026.

The patient is to continue tamoxifen combined with supportive therapy for three months and receive Zoladex 10.8 mg. The current plan is to maintain this regimen and monitor response at the next follow-up.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Reham Ahmed Fathy Ibrahim**

يعتمد ,

Patient's Data	Patient Name:	ياسمين خلف عبد الغني	
	Age: 34	Gender:	Female
	Referred By Prof. :	Ibrahim Abdel-Rahman	
		Thanks For Reference	
Clinical Diagnosis:	Right breast lesion		
Nature of the specimen:	Conservative surgery and axillary clearance		
Report issued At:	1-9-2020	Code Number:	HP4328-20

PATHOLOGY REPORT

Gross Pathology:

Two specimens were received, designated as;

A- Right BCS: a sector of mammary tissue piece measured 9x7cm covered with skin ellipse measured 6x2cm, it showed on ill-defined firm gritty hemorrhagic gray white mass measured 3.3x1.8cm, located (3cm,1.5cm,1.7cm,1.2 cm, and 0.6 cm) form (lateral medial, skin, superior, and inferior) margins respectively. Also received in the some container a mammary tissue piece measured 4x2.8cm, free of gross indurations.

B- Right axillary clearance axillary: tissue pieces measured 9x7.5cm, entangling 17 nodules up to 3x2cm.

Histology:

A- Sections examined reveal breast tissue infiltrated by invasive malignant growth made up by nests and groups of malignant large ductal cells with mild tubular differentiation, marked nuclear pleomorphism & hyperchromasia, increased nucleo/cytoplasmic ratio & prominent nucleoli. Positive for lymphovascular tumor emboli. Intraductal component is 5%.All surgical margins and skin are free.

2- Sections from the dissected axillary nodes show metastatic deposits in (2/17) lymph nodes with no extra capsular extension.

Diagnosis:

Infiltrating Duct Carcinoma, Grade II; Associated With 5% DCIS.

Positive For Lymphovascular Invasion.

Free Skin Covering.

Free Soft Tissue Resection Margins.

Positive Deposits With No Extracapsular Extension In Axillary Lymph Nodes (2/17).

#pTNM Stage= T_2N_1Mx.

Diagnosed By:

Dr\ Amr AL-Amaragy

Dr\ Hebat Allah Amin

NAME: Yasmine Khalaf A-Elghani
EXAM: US ABDOMEN & PELVIS DATE: 19/11/2022

REPORT

Real time US scanning of the abdomen and pelvis revealed:

- **The liver** is enlarged in size measuring about 17cm in MCL, and showing bright uniform echopattern with geographic, hypoechoic, avascular area seen anterior to gall bladder measures 12 x 13 mm. No intrahepatic biliary radicles. Normal caliber of the portal vein.
- **The gallbladder** shows average capacity and normal wall thickness. No gallstones or biliary mud detected.
- **The spleen** shows average and homogenous echotexture.
- **Both kidneys** show average size, regular outlines, normal parenchymal thickness and echogenicity. No renal calculi or back pressure changes seen.
- Normal appearance of **the pancreas, aorta and IVC.**
- **No ascites.**
- Average capacity and normal wall thickness of **the urinary bladder.** No masses or calculi.The lower ureters are free
- Average size of the Uterus with no myometrial focal lesions with homogenous endometrial echoes.
- No pathological adnexal solid or cystic lesions.

Opinion:

- **Bright hepatomegaly with area of focal fatty sparing.**

Best Regards,

Dr.Wafaa Heidar

مركز مكة للأشعة : برج الأطباء (الدور الأرضي) – 6 ش مدرسة الحلمية – ش زغلول – الهرم
Tel / Fax: (+20) 3 77 11 901 / Mobile: 0111 80 800 62 / 010 6 999 6 954

مستشفى أبو صفين
عيادات - عمليات - معمل تحاليل
أشعة عادية وتلفزيونية - رسم قلب
خدمة ٢٤ ساعة

NAME: Yasmeen Khalaf DATE: 23/8/2020

Pelvi-Abdominal Ultrasonography

LIVER : The liver is of average size (Bipolar dimension is 12.0 cm with homogeneous uniform texture. No focal lesions or dilated intra-hepatic biliary radicals
PV is patent & of average caliber

SPLEEN : Average size of the spleen (Bipolar dimension is 8.0 cm) It is of homogeneous uniform texture . No focal lesions seen

GB : The GB is of average size , average wall thickness
No stones no mud
Normal caliber of the CBD (3 mm)

KIDNEYS : Both are of normal size , Both are of normal cortical thickness and echopattern with good cortico-medullary differentiation no stones , cysts or back pressure changes

PLVIS : Normal filling of UB , no stones , masses or diverticulae
Average sized uterus , with homogenous myometrium
no adnexal masses or cysts

REMARKS : No ascites or lymphadenopathy
Normal appearance of the pancreas

Conclusion

- *Normal study*

apart from mild abdominal gaseous distention

Much Obliged, Yours
Dr. Sameh Abd Elhalim. MSc

نهاية شارع التحرير العمومى - صفط اللبن
ت : ٣٧٢٢٣٠٢٣

LIFE SCAN
Radiology & Lab

Name:yassmin khalaf abd el wahab
Prof. Dr:Khaled el sisi

age:34 y
Date: 5/12/2019

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE REVEALED:

Technique:

- Sagittal T1 and T2 WIs
- Axial T2 WIs

Findings:

- Preserved cervical curvature.
- Normal diameters of the bony spinal canal.
- No significant disc bulge or herniation seen.
- Normal MRI appearance of the cervical & dorsal spinal cord as well as the cervico-medullary junction. No intra spinal lesions seen.
- Normal marrow signal of the imaged vertebrae.
- No abnormality detected in the para-spinal soft tissues.

Opinion:

- Normal MRI study of the cervical spine.

Best Regards,

Dr. Bassem Ezzat Georgy

Sameh A. Z. Hanna, MD.
Prof. of Radiology – Cairo University

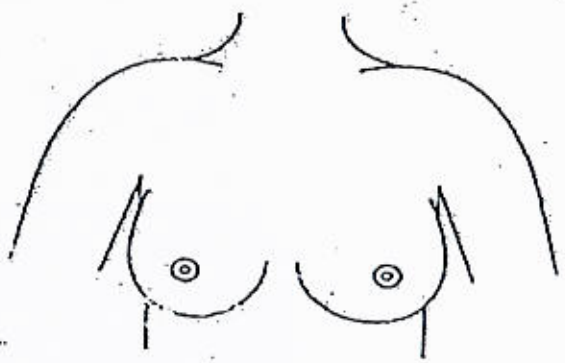
لايف سكان
للأشعة و التحاليل
15084
٨٧ شارع فيصل تقاطع المريوطية . الدور الأول . أسفل مستشفى تبارك . فيصل
١٢٣ شارع الوحدة تقاطع البوهي . الدور الأول . برج الضرائب . إمبابة
الشارع الجديد . تقاطع ترعة الشابوري . الدور الأول . أمام هايبر القدس . شبرا الخيمة

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
، هرمل ، سابقا

Name : [illegible]
Age : 34 y.
No.:

MDT FORM

Clinical data :



premenop. RT
Breast Cancer
IDC II
Mdj RT BCS
on 1/9/2020
T2, N1, Mo
ER+ve 7/8, PR+ve 7/8, Her2 3+
Ki67 10-20%.

Reason of discussion:

pt received Adj + 4 AC 1-12 Taxol
Herceptin

MDT Outcome and Plan

for Adjuv Herceptin
+ H ... o TC Zoladex
+ Tamoxifen

Signature :

[illegible]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECHON SUPPORT

تاريخ الاصدار :2023-11-15 جهه الاصدار :رئاسة الهيئة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) ياسمين خلف عبد الغنى على بطاقة رقم 28607072400281

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه :2023-11-15

الموظف المختص

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد

مسلسل 1144887

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]
MDT Form

جوستافروسي

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

10/12/2026

MDT FORM

Name:	Yasmin Khalaf Abd Elghany على	**MRN:**	8524
Age:	40 Y	**ID:**	28607072400281
Menopausal Sta	pre	**Phone:***	01207696550
NRS SCORE:		**Marital Status:**	married
BMI:		**Family History:**	no
Gender			
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	shift to AI
Surgical History:*	no	**ECOG Performance Status**	○ 0 ◉ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX:

ER: **PR:** **HER2:** **KI67:**

History:

40 y old female , premenopausal ,
upfront Rt BCS outside >> 9/2020 IDC , Grade II; Associated With 5% ,DCIS. , Positive For Lymphovascular Invasion. . Positive Deposits With No Extracapsular Extension In Axillary Lymph Nodes (2/17).
pTNM Stage= T2N1M0 >>> triple positive
recieved adjuvant chemo , anti HER2 , PORT
Tamoxifen since 4/2021 Zoladex since 10/2025
MDT for shift to AI + Zoladex

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

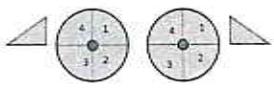
Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

Being high risk, shift to zoladex/AI for 2-3 years + zometa q 6 mths.

R L



T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د شيماء لاشين	د امنيه عيسوي		

12/10/26 12/10/2026